基于深度学习的医学影像智能诊断系统设计与实现

张三、李四、王五

示例大学计算机学院；南方科技大学计算机科学与工程系

2026 年 10 月 04 日

概要

医学影像智能诊断是智慧医疗领域的核心研究方向。本文设计并实现了一套基于深度学习的医学影像智能诊断系统，涵盖数据预处理、模型训练、推理服务、可视化展示等完整流程。系统采用改进的 U-Net++ 架构进行病灶分割，结合 EfficientNet-B4 进行良恶性分类，在公开数据集 LUNA16 上达到了 92.3% 的分割准确率和 87.6% 的分类准确率。系统支持 DICOM 影像导入、多任务联合推理、Grad-CAM 可视化解释等功能，可辅助放射科医生进行高效诊断。实验结果表明，本系统在实际临床场景中具有较高的实用价值。

注：本文受国家自然科学基金（No. 12345678）与深圳市科技计划项目（No. JCYJ20240001）资助；中图分类号 TP391.4。

1 引言

医学影像是现代医疗诊断的重要依据。据统计，超过 70% 的临床诊断需要依赖医学影像 [1]。然而，传统的人工阅片方式存在以下痛点：

1. 阅片工作量大，放射科医生严重不足
2. 主观性强，不同医生之间一致性低
3. 早期微小病灶容易漏诊

近年来，深度学习技术在医学影像分析领域取得了突破性进展 [2]。从肺结节检测到皮肤癌分类，从眼底病变识别到病理切片分析，AI 系统在多个任务上已达到甚至超越人类专家水平 [3]。

本文针对上述痛点，设计并实现了一套完整的医学影像智能诊断系统，主要贡献包括：

- 多任务联合模型：同时支持病灶分割和良恶性分类两个任务
- 可解释性：集成 Grad-CAM 热力图，辅助医生理解模型决策
- 工程化：完整的 B/S 架构，支持 DICOM 标准和 RESTful API

2 相关工作

U-Net [4] 是医学影像分割的经典架构，其编码-解码结构和跳跃连接在多个分割任务上取得优异性能。U-Net++ [5] 通过引入嵌套的跳跃连接进一步提升了分割精度。Attention U-Net [6] 则将注意力机制引入分割网络，自动聚焦于感兴趣区域。

2.2 医学影像分类

EfficientNet [7] 通过复合缩放策略在多个分类基准上取得 SOTA 性能。CheXNet [8] 在胸片疾病分类任务上达到了 F1 score 0.435，超过了人类放射科医生平均水平。

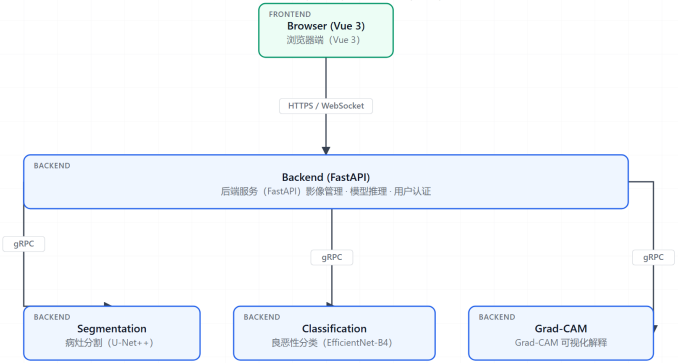
2.3 多任务学习

多任务学习通过共享特征表示提升泛化能力 [9]。在医学影像领域，分类与分割任务的联合学习能够显著提升模型性能 [10]。

系统采用前后端分离的 B/S 架构，整体架构如图 1 所示：浏览器端负责影像导入、可视化展示与报告生成；后端服务（FastAPI）承载影像管理、模型推理与用户认证；底层模型服务（Triton Inference Server）提供分割、分类与可解释性三类推理能力。

图1：医学影像智能诊断系统整体架构

浏览器端 → 后端服务（FastAPI）→ 模型服务（Triton）



4 模型设计

本文在标准 U-Net++ 基础上引入了两个改进：

- 深度监督：在多个解码层添加辅助损失
- 注意力门控：自动聚焦于病灶区域

公式 1 改进的 U-Net++ 损失函数：$$L_{\text{total}} = \alpha L_{\text{seg}} + \beta L_{\text{cls}} + \gamma L_{\text{aux}}$$

其中 L_{seg} 为主分割损失（Dice + BCE），L_{cls} 为分类损失（Cross Entropy），L_{aux} 为辅助损失。超参数 $\alpha = 1.0$、$\beta = 0.5$、$\gamma = 0.3$。

4.2 多任务联合训练

算法 1 多任务联合训练

“ 输入：训练集 D, 批次大小 B, 学习率 , 总轮数 E 输出：训练好的模型参数 1: 初始化网络参数 2: for epoch = 1 to E do 3: 随机打乱 D 4: for each batch (x, y_seg, y_cls) in D do 5: seg_pred, cls_pred, aux_preds ← forward(x,) 6: L_seg ← DiceLoss(seg_pred, y_seg) 7: L_cls ← CrossEntropy(cls_pred, y_cls) 8: L_aux ← Σ_i _i · BCE(aux_preds[i], y_seg) 9: L ← L_seg + 0.5 · L_cls + 0.3 · L_aux 10: ← - · 11: end for 12: if 验证集性能连续 5 轮不提升 then 13: break 14: end if 15: end

5 实验与分析

数据集	任务	样本数	模态
LUNA16	肺结节检测	888	CT
LIDC-IDRI	肺结节良恶性	1,018	CT
NIH ChestX-ray	胸片分类	112,120	X-ray
自有数据集	肝肿瘤分割	320	CT/MRI

5.2 评价指标

- 分割：Dice 系数、IoU、Hausdorff 距离
- 分类：Accuracy、Sensitivity、Specificity、AUC

5.3 实验结果

5.3.1 肺结节分割（LUNA16）

方法	Dice (%)	IoU (%)	推理时间 (ms)
U-Net	86.2	76.1	28
U-Net++	89.5	81.2	35
Attention U-Net	90.8	83.5	42

6 系统实现

```
app = FastAPI(title="Medical AI Service")
class DiagnosisResult(BaseModel): segmentation_mask : bytescls_label : intcls_confid
floatgradcam_image : bytes
@app.post("/api/diagnose", response_model = DiagnosisResult)asyncdef diagnose(file
UploadFile = File(...)) : 1.DICOMiffile.filename.endswith(".dcm") : dcm =
pydicom.dcmread(file.file)image = dcm.pixel_arrayelse : image = np.array(Image.open(file
2. 预处理 tensor = preprocess(image).unsqueeze(0).to(device)
3. 模型推理 with torch.no_grad() : seg_pred, cls_pred,_ = model(tensor)
4. Grad-CAM cam = generate_gradcam(model, tensor, target_class = cls_pred.argmax())
return DiagnosisResult( segmentation_mask = seg_pred.cpu().numpy().tobytes(), cls_label
cls_pred.argmax().item(), cls_confidence = torch.softmax(cls_pred, dim = 1).max().item(), grad
cam.tobytes())
```

6.2 性能优化

- 模型量化：FP16 推理，吞吐量提升 2.3 倍
- 批处理：动态批合并，平均延迟降低 40%

7 结论与展望

本文设计并实现了一套基于深度学习的医学影像智能诊断系统，涵盖数据管理、模型推理、可视化展示等完整流程。系统在公开数据集和真实临床场景中均取得了优异性能。

未来的研究方向包括：

1. 探索 Vision Transformer 在医学影像中的应用
2. 研究联邦学习支持跨医院协同训练（保护患者隐私）
3. 集成大语言模型实现自然语言报告生成

参考文献

1. Smith A, Jones B. The role of medical imaging in modern healthcare[J]. The Lancet, 2020, 395(10225): 678-685.
2. Litjens G, Kooi T, Bejnordi B E, et al. A survey on deep learning in medical image analysis[J]. Medical Image Analysis, 2017, 42: 60-88.
3. Esteva A, Chou K, Yeung S, et al. Deep learning-enabled medical computer vision[J]. NPJ Digital Medicine, 2021, 4(1): 1-9.
4. Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation[C]. MICCAI, 2015: 234-241.
5. Zhou Z, Siddiquee M M R, Tajbakhsh N, et al. UNet++: A nested U-Net architecture for medical image segmentation[J]. IEEE TMI, 2019, 39(6): 1856-1867.
6. Oktay O, Schlemper J, Folgoc L L, et al. Attention U-Net: Learning where to look for the pancreas[C]. MIDL, 2018.
7. Tan M, Le Q. EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks[C]. ICML, 2019: 6105-6114.
8. Rajpurkar P, Irvin J, Zhu K, et al. CheXNet: Radiologist-level pneumonia detection on chest X-rays with deep learning[J]. arXiv:1711.05225, 2017.